

Orthopédie Dento-Faciale (ODF)

Fascicule 12 · Prévention, dépistage, diagnostic et traitement des malpositions

ODF : science qui a pour objet la prévention, le dépistage, le diagnostic et le traitement des malformations et malpositions de la face, des maxillaires, des arcades dentaires et des dents.

Orthodontie : mêmes buts mais uniquement au niveau des **arcades dentaires, os alvéolaire et dents**. C'est une partie de l'ODF.

Buts de l'ODF

3 grands buts

Indications : À connaître pour comprendre les indications

Étape	Matériel
Fonctionnels	Rétablir une bonne occlusion
Esthétiques	Harmonie du sourire et du visage
Préventifs	Bonne occlusion → meilleure hygiène → prévient caries et parodontopathies · prévient troubles de l'ATM · intercepte les mauvaises habitudes

Classification d'Angle — à connaître par cœur

Les 3 classes d'occlusion

Indications : Référence anatomique : rapport de la 1re molaire maxillaire/mandibulaire

Étape	Matériel
Classe I	Occlusion harmonieuse — pas de décalage antéro-postérieur entre maxillaire et mandibule
Classe II	Maxillaire en avant de la mandibule (rétrognathie mandibulaire ou prognathie maxillaire)
Classe III	Mandibule en avant du maxillaire (prognathie mandibulaire ou rétrognathie maxillaire)

Principes du déplacement dentaire

Le déplacement est possible grâce à une propriété de l'os : il se **remodèle toute la vie** par destruction et reconstruction. L'appareil exerce une force sur la racine → propagée au ligament et à l'os → l'os se détruit en regard de la pression et se reconstruit derrière la racine. **D'où l'intérêt de la contention post-traitement** pour stabiliser le résultat.

Déroulement d'un traitement ODF

Étape 1 — Dossier ODF (examen clinique + paraclinique)

Indications : Récolte des données de diagnostic

Étape	Matériel
Examen extra-buccal	Examen de la face · muscles faciaux au repos · muscles faciaux en fonction
Examen intra-buccal	Arcades · dents et parodonte · freins · OIM (Occlusion d'Intercuspitation Maximale) · hygiène
Examen fonctions oro-faciales	Ventilation · phonation · déglutition · mastication · succion · incompétence labiale
Examen paraclinique	Moulages d'étude (alginate, mesure dents et arcades) · panoramique dentaire (bilan) · téléradiographie du crâne de profil + étude céphalométrique (croissance faciale, mesure des dysmorphoses)

Étape 2 — Traitement PRÉVENTIF

Indications : Dépister les troubles mineurs facilement traitables chez le jeune enfant

Étape	Matériel
Buts	Prévenir l'apparition des malformations OU empêcher leur aggravation
Exemples	Dépister les troubles d'origine fonctionnelle (succion du pouce, déglutition atypique, ventilation buccale)

Étape 3 — Traitement INTERCEPTIF

Indications : Corriger précocement une dysmorphose pour éviter le traitement actif

Étape	Matériel
Appareils fonctionnels / physiologiques	ELN (Enveloppe Linguale Nocturne) — éducation de la position de langue la nuit
Appareils amovibles	Plaque à vérin · plaque palatine
Appareils fixes (bibagues)	Quad-hélix · disjoncteur maxillaire

Étape 4 — Traitement ACTIF

Indications : En denture permanente — déplace activement les dents

Étape	Matériel
Type	Appareillages multi-attaches (bagues collées + arcs métalliques)
Techniques	Edgewise (technique classique) · technique linguale (bagues côté palatin, invisibles) · Damon (auto-ligaturant) · aligneurs transparents (Invisalign)
Compléments extra-oraux	Force extra-orale (FEO) · masque facial · mentonnière (selon le cas)

Étape 5 — CONTENTION (cruciale !)

Indications : Maintien du résultat après traitement actif

Étape	Matériel
Pourquoi	L'os continue de se remodeler après l'arrêt du traitement — sans contention le résultat se perd
Moyens	Fil collé en lingual (contention fixe) · gouttière thermoformée nocturne (contention amovible)

Rôle de l'AD en ODF : accueillir le patient (souvent jeune) · préparer les empreintes d'étude · gérer l'agenda des RDV de pose / activation / contrôle · informer sur l'hygiène spécifique aux multi-attaches (brossette interdentaire, fil dentaire avec passe-fil, gel fluoré) · stériliser les instruments · rassurer.